

TOC — Trastorno Obsesivo-Compulsivo

TCC — Ficha clínica

DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO

El TOC se caracteriza por obsesiones (pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos y recurrentes) y compulsiones (conductas o actos mentales orientados a reducir la ansiedad). La **Exposición con Prevención de Respuesta (ERP)** es el tratamiento de primera línea, con evidencia robusta. El modelo cognitivo de Salkovskis (1985) propone que la **sobre responsabilidad** es el factor central de mantenimiento.

TÉCNICAS E INTERVENCIONES TCC — PASO A PASO

1	Psicoeducación del ciclo Normalizar pensamientos intrusos (todos los tienen). Explicar cómo la compulsión reduce la ansiedad a corto plazo y la refuerza a largo plazo. Diferenciar pensamiento intrusivo de intención.
2	Evaluación cognitiva de creencias obsesivas Identificar creencias disfuncionales: sobre responsabilidad, importancia de los pensamientos, intolerancia a la incertidumbre, perfeccionismo, sobreestimación del peligro. Usar inventarios específicos (OBQ-44).
3	Jerarquía de exposición Listar situaciones, objetos o pensamientos que generan obsesiones. Ordenar de menor a mayor SUDS (0-100). Comenzar en 30-40 SUDS. Cada ítem debe trabajarse hasta habituación antes de subir.
4	ERP — Exposición con Prevención de Respuesta Exponer al estímulo disparador (objeto, situación, pensamiento). Impedir la compulsión por completo — no parcialmente. Permanecer en la situación hasta que la ansiedad baje al menos 50%. Registrar curva de ansiedad.
5	Exposición imaginaria (para obsesiones puras) Para contenidos mentales (sin estímulo externo). Escribir o grabar el pensamiento temido. Exposición repetida a la grabación/texto hasta habituación. Fundamental en TOC de contaminación mental o daño.
6	Reestructuración de creencias de sobreresponsabilidad Trabajar la creencia de que tener un pensamiento equivale a ser responsable de actuar sobre él. Ejercicio de 'pastel de responsabilidad'. Gráfico de todos los factores que contribuirían al daño temido.
7	Prevención de recaídas Identificar señales de recaída. Plan de acción con ERP autoguiado. Normalizar el retorno ocasional de las obsesiones. Practicar ERP.

ADAPTACIONES POR POBLACIÓN

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adultos	Involucrar a familiares en la psicoeducación. Trabajar acomodación familiar (conductas de los otros que refuerzan el TOC). La ERP debe ser rigurosa — no hacer concesiones.

TOC — Trastorno Obsesivo-Compulsivo

TCC — Ficha clínica

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adolescentes	Alta acomodación familiar — trabajar con padres en paralelo. El TOC puede afectar significativamente el rendimiento escolar y relaciones de pares. Psicoeducación específica sobre egodistonia.
Niños (desde 5-6 años)	El TOC puede presentarse como rituales de sueño, conductas repetitivas o miedos específicos. Adaptar la ERP

Clave clínica: La prevención de respuesta es no negociable: cualquier compulsión, incluso parcial, refuerza el ciclo. Paciente y terapeuta deben tolerar la ansiedad sin 'ayudarla' a bajar artificialmente.